

시술 이후를 팝니다

병원의 기존 환자에게 재방문 상품을 설계해 파는 사업

새로운 시장에 들어가는 제안이 아닙니다. 우리가 이미 20년간 해 온 일, 병원의 매출을 올리는 일을 상품 형태로 포장해 파는 제안입니다. 공간도, 재고도, 개발도, 광고도 필요하지 않습니다. 필요한 것은 이미 우리에게 있는 **원장 관계와 병원 손익 구조에 대한 이해, 상담실 언어**뿐입니다.

우리가 파는 것

시술 이후 4주를 설계한 **프로그램과 설문, 스크립트, 매뉴얼** 한 세트

누구에게

이미 환자와 공간을 가진 병원에게. **소비자가 아니라 원장이 고객**입니다

얼마에

셋업 300만원 + 해당 프로그램 **매출 쉐어 15%** (가설)

90일 뒤

계약서 한 장과 첫 정산서 한 장. 그것이 이 90일의 완료 정의입니다

제안 범위

사업 정의 / 진단 질문지 / 환자 설문 / 프로그램 설계
과금 구조 / 90일 실행 / RE:IV로 가는 경로

고객

강남권 시술 중심
성형외과와 피부과

필요 자본

인건비 외 90일 5백만원 내외
공간과 재고, 개발, 광고 없음

문서 기준

2026.08.16
본문 숫자는 전부 가설

ONE LINE

병원이 이미 가진 환자에게, 다시 올 이유를 만들어 판다.

고객은 소비자가 아니라 병원입니다. 상품은 공간이 아니라 시술 이후의 설계입니다. 우리는 환자를 데려오지 않고, 병원이 이미 데려온 환자의 다음 90일을 만듭니다.

고객	강남권 시술 중심 성형외과와 피부과. 내부 네트워크를 통해 원장과 직접 연결되는 곳부터 시작합니다.
문제	병원은 시술을 팔고, 시술 이후는 팔지 않습니다. 회복 기간에 상품이 없어 관계가 끊기고, 끊긴 환자는 다시 광고비를 써서 사옵니다.
상품	① 병원 진단 리포트, ② 환자 애프터케어 설문, ③ 시술별 프로그램 설계, ④ 상담실장 스크립트, ⑤ 운영 매뉴얼과 월간 성과 리포트
과금	셋업비 + 해당 프로그램 매출 쉐어 (가설: 파일럿 300만원 + 15%)
왜 우리	원장 20년 관계와 병원 손익 구조에 대한 이해, 상담실 언어, 의료광고법 감각. 돈으로 살 수 없고, 자본으로 이길 수 없는 자산입니다.
90일 목표	PoC 유료 병원 1곳 계약 및 운영 개시 - 계약서와 셋업비 입금.
12개월 목표	병원 5곳 운영 데이터로 RE:IV 1호점 설계를 실측으로 작성. 이후 IP, 라이선스, PB로 확장.
필요 자본	인건비 외 90일 5백만원 내외. 임차와 인테리어, 장비, 재고, 개발, 광고비 없음.

우리가 파고드는 구간 - 환자 한 명의 1년

지금의 병원	광고비로 유입 1인당 20~40만원	시술 1회 이 구간만 상품이 있음	상품이 없는 90일 - 관계가 끊기는 구간 병원은 아무것도 팔지 않고, 환자는 다음 병원의 광고를 봅니다	다시 광고비 같은 환자를 다시 구매
제안 이후	광고비로 유입 동일 - 여기는 건드리지 않음	시술 1회 + 설문 60~90초, 태블릿	D0, D3-5, D14, D28 - 우리가 만드는 4번의 재방문 유휴 베드와 이미 산 장비로 운영. 병원 기여이익 가설 36만원 / 환자 1인	다음 시술로 광고비 없이 재방문

가장 중요한 문장

이 사업의 원가는 공간이 아니라 우리가 아는 원장의 수입입니다. 그래서 첫 매출까지의 거리가 가장 짧습니다.

공간은 포기하는 것이 아니라 순서가 바뀝니다

파일럿을 5곳 돌리면 그중에서 "우리 병원에 아예 층으로 내자"는 원장이 나옵니다. 1호점은 M13에서 M18 사이, 실제 매출 데이터를 들고 옵니다.

지난 몇 달의 검토는 **시장을 해석하는 회사**가 되는 쪽으로 진행됐습니다. 그 방향의 결론 자체가 "우리가 아직 갖지 못한 것"의 목록이었습니다. 이 제안은 방향을 뒤집습니다.

노선 A - 검토해 온 방향

시장을 해석하는 회사 미디어와 데이터, 플랫폼, 아카데미

그 검토의 결론이 요구한 것들:

- 2명 신규 채용 (에디토리얼과 프로덕트)
- 사이트와 CMS, DB, 서버이 개발
- 90일간 30건 이상 오리지널 콘텐츠 발행
- 현장 유료 체험 6곳, 운영자 인터뷰 10곳
- 서버이 응답 200~300건 확보
- 그 다음에야 유료 고객 1건 시도

문제는 옳고 그름이 아닙니다

이 노선은 **우리가 아직 갖지 못한 능력**(콘텐츠 생산력과 개발, 데이터 자산)으로 승부하고, 자본을 이미 투입한 상대와 같은 판에서 만납니다. 첫 매출까지 최소 6개월, 그 매출도 "정보에 돈을 낼 사람이 있는가"라는 가정 위에 있습니다.

그 문서가 스스로 내린 결론

"우리가 되지 말아야 할 것" 목록에 **복합 공간과 진단 플랫폼, 멤버십 클럽, 병원 MSO**가 모두 올라가 있습니다. 남은 자리는 **중립적인 해설자**였고, 그 자리는 **매출까지의 거리가 가장 먼 자리**입니다.

이 노선은 "우리가 무엇을 알고 있는가"에 답합니다.

노선 B - 이 문서가 제안하는 방향

병원의 빈 구간을 상품으로 만드는 회사 이미 있는 환자와 이미 있는 공간, 이미 있는 관계

이 노선이 요구하는 것들:

- 신규 채용 **0명** - 지금 두 사람이면 시작됩니다
- 개발 **0원** - 설문은 태블릿 폼과 카톡으로 충분합니다
- 콘텐츠 **0건** - 우리가 파는 것은 조회수가 아닙니다
- 내부 네트워크로 확보된 원장 리스트 **20곳**
- 무상 진단 리포트 1장으로 첫 미팅을 엽니다
- 첫 계약까지 목표 **90일**

이 노선의 승부처는 우리가 이미 이긴 자리입니다

원장을 만날 수 있는가, 병원 손익을 읽을 수 있는가, 상담실장이 쓸 문장을 쓸 수 있는가. 세 가지 모두 지금 우리에게 있습니다. 배워야 할 것이 없다는 점이 이 노선의 유일하고 결정적인 강점입니다.

그리고 노선 A를 버리는 것이 아닙니다

파일럿 병원의 정산서가 쌓이면 그것이 어떤 **시장 리포트보다 정확한 데이터**가 됩니다. **매출이 먼저고 해석은 그 다음입니다.** 순서를 바꾸는 제안이지, 방향을 지우는 제안이 아닙니다.

이 노선은 "우리가 무엇을 팔 수 있는가"에 답합니다.

비교 축	노선 A - 시장을 해석하는 회사	노선 B - 병원에 상품을 파는 회사
승부 자산	콘텐츠 생산력과 개발, 축적 데이터 (아직 없음)	원장 관계와 병원 손익 이해, 상담 언어 (이미 있음)
첫 매출까지	6~12개월	2~3개월
한 번 실패하면	포지셔닝부터 다시	다음 병원으로
결론	지금의 우리에게서 이르다	지금의 우리가 가장 잘할 수 있다

#	납품물	병원이 실제로 받는 것	이 상품이 없으면
①	병원 진단 리포트	13개 질문에 대한 답으로 계산한 "이 병원이 지금 놓치고 있는 재방문 매출" 1장. 무상 제공하며, 이것이 첫 미팅의 유일한 도구입니다.	원장은 우리를 만날 이유가 없습니다
②	환자 애프터케어 설문	내원 환자용 10문항, 60~90초. 차트 연동 시 환자가 답하는 것은 5문항. 태블릿 또는 카톡으로 운영합니다.	권할 명분과 근거 데이터가 없습니다
③	시술별 프로그램	시술군 × 회복 곡선에 맞춘 D0-D28 사이클 설계. 5개 축(처치와 장비, 홈케어, 생활, 기록)의 조합이며, 수액은 그중 하나일 뿐입니다.	팔 물건 자체가 없습니다
④	상담실장 스크립트	언제 누구에게 어떤 문장으로 권하는가. 환자 응답별 분기와 거절 대응까지 문장 단위로 제공합니다.	프로그램이 좋아도 매출은 0입니다
⑤	운영 매뉴얼, 성과 리포트	동선과 인력 배치, 단가표, 예약 규칙 / 월간 전환율과 재방문율, 프로그램별 기여이익.	2개월 뒤 아무도 운영하지 않습니다

이 상품의 심장

④ 스크립트

아무리 좋은 프로그램을 넣어도 **상담실장이 권하지 못하면 매출은 0**입니다. 반대로 스크립트가 좋으면 프로그램이 평범해도 팔립니다.

그리고 이것은 우리가 20년간 해 온 일 그 자체이며, **자본으로 복제되지 않는 유일한 지점**입니다. 경쟁자는 장비를 살 수 있고 공간을 지을 수 있지만, 상담실에서 통하는 문장은 살 수 없습니다.

실제 납품 형태 - 스크립트 한 조각

[시점] 시술 종료 직후, 환자가 옷을 갈아입고 나온 시점. 수납 전.

[조건] 설문 Q10 = 1번 & Q4 = "붓기, 멍" 응답자

[문장] "아까 붓기 오래갈까 봐 걱정된다고 하셨죠. 그 부분만 잡아주는 관리가 있는데, 지금 예약하시면 3일 뒤에 한 번 오시는 게 제일 효과가 좋아요. 오늘 하실 필요는 없고 일정만 잡아두시면 됩니다."

[거절 시] "네, 그럼 3일 뒤에 붓기 어떠신지만 문자로 여쭙볼게요." - 거절을 D+3 재접촉 동의로 전환

우리가 하지 않는 것

범위를 좁히는 것이 이 사업의 안전장치입니다.

- 환자를 소개하지 않습니다. 신규 유입은 우리 영역이 아니며, 법적으로도 위험한 구간입니다
- 진료, 처방에 관여하지 않습니다. 모든 의료 판단과 책임은 병원에 있습니다
- 장비를 팔지 않습니다. 병원이 이미 가진 장비의 가동률을 올립니다
- 공간을 짓지 않습니다. 병원의 유휴 베드를 씁니다
- 병원 경영 전반을 맡지 않습니다. 애프터케어 한 구간만 책임집니다

좁힐수록 팔기 쉬워집니다

원장이 "이건 우리 병원을 바꾸는 일"이라고 느끼면 결정이 6개월 걸립니다. "프로그램 하나 넣는 일"이면 2주면 됩니다.

납품 방식

전달 형태	인쇄 바인더 1권 + 태블릿 설문 링크 + 상담실 코팅 카드 (개발, 설치 불필요)
교육	상담실장, 관리자 대상 1회 90분 세션 + 2주 뒤 현장 점검 1회
개정	첫 30일 실측 데이터로 스크립트와 단가를 1회 무상 개정
소유권	납품물의 저작권은 우리에게, 사용권은 계약 기간 동안 병원에

04 STEP 1 - 병원에 묻는 것

첫 미팅에서 이 13개의 답만 받으면, 그날 저녁에 "이 병원이 놓치고 있는 매출"을 계산해 드릴 수 있습니다

제안서를 들고 가지 않습니다. 질문지를 들고 갑니다. 원장은 자기 병원 이야기를 하는 자리는 거절하지 않습니다. 그리고 이 13개의 답은 그대로 우리의 첫 자산이 됩니다.

#	질문	받는 형태
Q1	월 시술 실환자 수는 몇 명입니까? (건수 아닌 사람 수)	명 / 월
Q2	이 중 90일 안에 다시 오는 환자는 몇 %입니까? 그 환자들은 어떤 경로로 다시 옵니까?	% + 경로
Q3	신규 : 기존 환자 비율은?	% : %
Q4	신규 환자 1명을 데려오는 데 쓰는 돈은? (월 광고비 ÷ 월 신규 환자)	원 / 명
Q5	상담 → 시술 전환율은?	%
Q6	시술별 객단가 분포와 현재 가장 비싼 패키지 가격은?	원 / 구간별
Q7	피부관리실 베드 몇 개, 관리사 몇 명, 하루 평균 몇 시간 가동됩니까?	개 / 명 / h

#	질문	받는 형태
Q8	보유 장비 목록과 각각의 하루 가동 횟수는? 거의 안 쓰는 장비가 있습니까?	목록 + 회/일
Q9	지금 시술 후에 무상으로 나가는 관리, 제품이 있습니까? 월 원가로 얼마입니까?	항목 + 원/월
Q10	시술 후 환자 컴플레인 상위 3개는 무엇입니까?	3개 문장
Q11	상담실장 몇 명이며, 인센티브는 무엇에 붙습니까?	명 + 구조
Q12	월 마케팅 예산과 채널 비중은?	원 / 채널
Q13	지금 병원에서 가장 아까운 것 한 가지를 꼽으면 무엇입니까?	자유 응답
산출	무상 진단 리포트 1장 - 재방문 갯 × 객단가 = 지금 놓치고 있는 연간 매출	

그날 저녁에 만들어 다음 날 보내는 것 - 무상 진단 리포트 1장 (아래는 가상의 병원 예시)

월 시술 실환자 (Q1)	200명	유휴 베드 (Q7)	9개 중 일 4.5시간 공백	리포트 마지막 줄 원장님은 이미 있는 환자를 연 5.8억으로 다시 사고 계십니다. 이 문장 하나가 두 번째 미팅을 만듭니다. 제안도, 견적도 아직 꺼내지 않습니다.
90일 재방문율 (Q2)	22%	가동을 낮은 장비 (Q8)	3종	
신규 환자 획득 비용 (Q4)	310,000원	무상으로 나가던 관리 (Q9)	월 원가 220만원	
재방문하지 않는 환자	월 156명	즉시 상품화 가능한 자산	신규 투자 0원	
이들을 다시 사오는 비용	월 4,836만원	전환율 15% 가정 시 순증	월 567만원	

Q4 × Q2 가 이 미팅의 핵심입니다

신규 1명에 30만원을 쓰면서 90일 재방문율이 20%라면, 원장은 매달 자기 환자를 버리고 다시 사오고 있는 것입니다. 이 문장 하나가 계약을 만듭니다.

Q7, Q8, Q9는 원가 0원짜리 매출을 찾는 질문입니다

유휴 베드와 안 쓰는 장비, 이미 무상으로 나가던 관리. 세 가지를 묶으면 신규 투자 없이 유상 프로그램이 하나 만들어집니다.

Q13 은 우리가 팔 것을 원장이 직접 말하게 합니다

여기서 나온 문장을 그대로 제안서 첫 줄에 씁니다. 원장은 자기 문장을 반박하지 않습니다.

05 STEP 2 - 환자에게 묻는 것 (1/2)

시술 상담 직후 또는 시술 당일, 태블릿 60~90초, Q1~Q3은 차트 연동 시 자동 입력

목적은 세 가지입니다. ① 환자에게 맞는 프로그램을 매칭하고 ② 상담실장에게 권한 명분을 주고 ③ 병원과 우리에게 상태 데이터를 남깁니다. 모든 문항은 마지막 줄에 "이 질문이 매출로 연결되는 방식"을 함께 설계했습니다.

Q1 오늘 받으신(또는 상담하신) 시술은 무엇인가요?

단일 - 자동입력

인모드 슈링크 올세라 써마지 올리지오 실리프팅 레이저토닝 피코 브이빔, 엑셀브이
제네시스 필러 보톡스 리췌란, 주베룩 물광, 스킨부스터 포텐자, 실핏엑스 지방분해주사
지방흡입 눈, 코 수술

왜 묻는가 - 시술명이 회복 곡선과 금기사항, 프로그램 사이클 길이를 결정합니다. 병원별로 실제 취급 시술명으로 교체해 납품합니다.

Q2 시술 부위는 어디인가요?

복수 - 자동입력

얼굴 전체 이마 눈가 볼, 팔자 하관, 턱선 목 복부 허벅지, 팔 두피

왜 묻는가 - 부위에 따라 붓기 지속일과 노출 부담이 다릅니다. 하관과 목은 **4주 사이클**, 눈가는 **2주 사이클**로 분기합니다.

Q3 시술 강도는 어느 정도였나요?

단일 - 자동입력

가볍게 (마취 없이) 보통 (연고 마취) 강하게 (수면 또는 국소 마취) 수술적 처치

왜 묻는가 - 다운타임 예측의 핵심 변수. 강도가 높을수록 D0 당일 케어의 필요성과 **지불 의향이 함께 올라갑니다.**

Q4 지금 가장 신경 쓰이는 부분은 무엇인가요?

단일 - 메인 코드 결정

붓기나 멍이 오래 갈까 봐 **RE:HEAL** 일상 복귀가 늦어질까 봐 **RE:HEAL** 효과가 금방 돌아올까 봐 **RE:GLOW**
피부 컨디션이 예전 같지 않아서 **RE:AGE** 아픈 게 겁나서 **RE:HEAL** 특별히 없습니다

왜 묻는가 - 환자가 스스로 불안을 말하게 하는 문항. 상담실장은 이 문장을 그대로 인용합니다. "아까 붓기 오래갈까 걱정된다고 하셨죠."

Q5 이전에 시술을 받고 실제로 겪으신 것이 있나요?

복수

붓기가 3일 넘게 갔다 멍이 크게 들었다 열감과 홍조가 오래갔다 생각보다 아팠다 효과를 잘 못 느꼈다
효과가 금방 사라졌다 일정에 지장이 있었다 이번이 처음이다

왜 묻는가 - 애프터케어는 미래의 이득이 아니라 **과거의 불편이 반복되지 않는다는 약속**으로 팔립니다. 이 문항이 가장 강한 구매 근거를 만듭니다.

Q6 앞으로 한 달 안에 중요한 일정이 있으신가요?

단일 + 날짜

결혼, 상견례 촬영, 방송 중요한 미팅, 발표 여행, 출장 행사, 모임 없습니다

있다면 날짜 __월 __일 → D-day 자동 계산

왜 묻는가 - 긴급도가 곧 객단가입니다. D-14 이내 일정이 있는 환자는 자동으로 집중 티어(RE:BOOT)로 상향되고, 남은 일수에 맞춰 세션이 압축 배치됩니다.

Q7 병원에 다시 오실 수 있는 빈도는 어느 정도인가요?

단일 - 상품 형태 결정

주 2회 이상 가능 주 1회 가능 2주에 1회 월 1회 시간 내기 어렵다

왜 묻는가 - 내원형 패키지와 홈케어형 패키지를 가르는 문항. "시간이 없다"는 환자에게 4주 내원 프로그램을 권하면 환불로 돌아옵니다.

Q8 요즘 해당되는 것을 모두 골라주세요.

복수 - 확장 + 안전

잠이 부족하다 쉽게 지치고 회복이 느리다 붓기가 잘 안 빠진다 스트레스가 많다 술자리와 야근이 잦다
다이어트 중이다

복용 중인 약이나 영양제가 있다

시술 부위에 트러블이나 염증이 있다

임신 또는 수유 중이다

해당 없음

왜 묻는가 - 앞줄은 **시술과 무관한 전신 상태**를 잡아 정기 프로그램으로 확장시킵니다(RE:CHARGE). 뒷줄은 **안전 스크리닝**으로, 해당 시의요진 확인 플래그가 붙습니다.

Q9 회복 관리를 준비한다면, 어느 쪽이 더 편하신가요?

단일 - 티어 탐색

부담 없이 꼭 필요한 것만 병원에서 관리받는 쪽이 마음이 놓인다 집에서 혼자 할 수 있으면 좋겠다
일정에 맞춰 확실하게

왜 묻는가 - 예산을 직접 묻지 않습니다. **가격을 묻는 순간 방어가 생깁니다.** 선호로 티어를 추정하고, 맞는 가격대 하나만 제시합니다.

Q10 시술 결과를 더 좋게 하고 회복을 앞당기는 관리가 있다면 안내받으시겠어요?

단일 - 전환 트리거

네, 오늘 안내받고 싶습니다 네, 나중에 안내받고 싶습니다 지금은 괜찮습니다

왜 묻는가 - 1번은 **당일 상담**, 2번은 **시술 후 D+3 알림** 대상으로 분리 관리. 마케팅 수신 동의를 연결하는 지점이기도 합니다.

RE:HEAL 회복형 붓기와 멍, 다운타임이 걱정. 시술 직후 회복 가속이 필요한 상태. 가장 큰 불륜.	RE:GLOW 지속형 효과가 금방 돌아온다고 느끼는 상태. 시술 결과의 유지와 부스팅이 목적.	RE:BOOT 일정형 2주 내 중요한 자리. 단기 집중. 객단가가 가장 높은 구간.	RE:CHARGE 컨디션형 수면 부족과 만성 피로, 잦은 술자리. 시술과 무관한 전신 상태. 정기 프로그램으로 확장.	RE:AGE 장기관리형 회복력 저하와 노화 체감. 분기 단위 관리 프로그램으로 연결.
--	---	--	---	--

단계	규칙
메인 코드	Q4 응답을 메인 코드로 확정. 환자가 스스로 말한 불만이 가장 강한 구매 동기이기 때문입니다.
코드 보강	Q5에서 "붓기 3일 이상" 또는 "멍" 선택 시 → RE:HEAL 강도 상향. "효과 못 느낌 / 금방 사라짐" 선택 시 → RE:GLOW로 메인 코드 덮어쓰기.
티어 결정	Q6에 D-14 이내 일정이 있으면 무조건 집중 티어(RE:BOOT)로 상향. 그 외에는 기본 티어.
상품 형태	Q7이 "시간 내기 어렵다"면 내원형 패키지를 제안하지 않습니다. 홈케어 키트 + 원격 체크인 구성으로 자동 전환.
서비스 코드	Q8 앞줄에서 2개 이상 선택 시 RE:CHARGE를 서비스 코드로 병기 → 정기 프로그램 제안 대상으로 별도 관리.
가격대	Q9 응답으로 티어를 추정하고, 상담실장은 맞는 가격대 하나만 제시합니다.
상담 분기	Q10이 1번 → 당일 상담 / 2번 → 시술 후 D+3 알림 / 3번 → D+14 후기 요청만

설계 원칙

메뉴를 나열해서 고르게 하지 않습니다

환자가 보는 것은 코드 하나와 깊이 하나뿐입니다. 메뉴의 복잡도는 병원 내부에만 존재하고, 환자 화면에서는 사라집니다.

선택지를 늘리면 전환율이 떨어집니다. 우리가 파는 것은 선택권이 아니라 "당신은 이겁니다"라는 판정입니다.

안전 플래그

Q8 뒷줄(복용 약, 트러블, 임신과 수유)에 하나라도 체크되면 프로그램 자동 제안이 정지되고 의료진 확인 단계로 넘어갑니다. 우리 설계가 의료 판단을 대신하지 않는다는 것을 문서와 시스템 양쪽에서 명시합니다.

판정 예시 - 같은 날 온 환자 3명이 서로 다른 상품을 받는 방식					
환자	설문 응답 요약	판정	제안되는 구성	가설 판매가	상담 시점
A	인모드 하관 / 강하게 / 붓기 걱정 / 지난번 붓기 3일 이상 / 주 1회 가능 / 일정 없음	RE:HEAL 기본 티어	4주 4세션 - 수액 + 쿨링과 LED + 림프 관리 + 홈케어 키트	600,000원	당일, 수납 전
B	레이저토닝 얼굴 전체 / 보통 / 효과 지속 걱정 / D-10 촬영 일정 / 주 2회 이상 가능	RE:BOOT 집중 티어 상향	10일 4세션 압축 - 재생 부스팅 2회 + 진정과 보습 2회 + 촬영 전날 컨디셔닝	890,000원	당일, 즉시 예약
C	필러 눈가 / 가볍게 / 특별한 걱정 없음 / 시간 내기 어렵다 / 수면 부족, 야근 잦음 2개 선택	RE:HEAL 서비스 RE:CHARGE	내원형 제안하지 않음 - 홈케어 키트 + D+3 원격 체크인. 이후 정기 프로그램 제안 대상	150,000원	D+3 알림
환자 C처럼 팔지 않는 판정이 나오는 것이 이 설계의 신뢰 장치입니다. 모두에게 60만원짜리를 권하는 순간 상담실장이 스크립트를 쓰지 않게 되고, 프로그램 전체가 2개월 만에 멈춥니다.					

07 프로그램은 무엇으로 만들어지는가

수액만 파는 사업이라면 이 제안은 성립하지 않습니다. 수액은 5개 축 중 하나이고, 매출의 대부분은 다른 축에서 나옵니다

핵심은 **병원이 이미 가지고 있는데 돈이 되지 않고 있는 자산**입니다. 빈 베드, 안 쓰는 장비, 이미 무상으로 나가던 관리. 이 셋을 묶으면 **신규 투자 0원으로 유상 프로그램이 하나 만들어집니다.**

구 성 축	실제 구성 요소	누가 하는가	병원의 신규 투자	매출 기여
01 의료 처치	항산화와 재생 수액, 부기와 항염을 잡는 국소 주사, 소염과 진정 처방약, 스킨부스터 소량 분할 시술, 필요 시 재생 레이저 1회 보정	의사, 간호	없음 (기존 재료)	중
02 장비 케어	병원이 이미 보유한 장비의 저출력 프로토콜 - LED(적색과 근적외), 저출력 레이저, 쿨링과 냉각, 고주파 소출력, 초음파 도자, 산소와 수분 공급, 림프 순환 마사지	피부관리사	0원 - 유휴 자산	최대
03 홈케어 키트	재생 크림, 진정 마스크, 색소와 흉터 관리제, 자외선 차단, 부위별 전용 제품(목, 두피), D0~D28 사용 순서가 인쇄된 카드	패키지 동봉	사입 원가만	높음
04 생활 프로토콜	음주, 사우나, 운동, 수면, 염분, 자외선, 화장 재개 시점 가이드를 D0/D1/D3/D7/D14/D28 카카오톡 자동 발송 으로 구성	자동 발송	0원	낮음 (재방문 유도)
05 측정, 기록	표준 조명과 각도로 찍는 전후 사진, 붓기와 흉반 자가 스코어(0-10), D28 비교 리포트 출력물	데스크, 관리사	0원	낮음 (재계약 장치)

축 02 상세 - 병원이 이미 가진 것으로 만드는 애프터케어 프로토콜 (신규 구매 0원)			
병원 보유 자산	애프터케어 전용 프로토콜	어느 코드, 어느 시점에 들어가는가	1회 소요
LED 장비 (적색과 근적외)	저출력 진정과 재생 조사	RE:HEAL D0 / D14 - 거의 모든 시술군에 공통 적용 가능한 기본 모듈	15~20분
쿨링 기기	열감과 부기 초기 진정	RE:HEAL D0 - 리프팅과 레이저 직후 만족도를 가장 크게 움직이는 구간	10~15분
고주파와 초음파 도자	소출력 순환 촉진 프로토콜	RE:HEAL D3-5 / RE:GLOW D14 - 시술 강도에 따라 출력 하향 운용	20분
피부관리실 베드와 관리사	림프 순환 수기 관리	RE:HEAL D3-5 / RE:BOOT 집중 구간 - 유휴 시간대에 배치	20~30분
산소와 수분 공급 기기	진정과 보습 마무리	전 코드 공통 마무리 모듈 - 환자 체감 만족도를 담당	10분
거의 쓰지 않는 장비	애프터케어 전용으로 용도 재정의	진단 Q8에서 확인된 유휴 장비를 프로토콜의 주 구성으로 편입 - 원장에게 가장 설득력 있는 지점	병원별 설계
이 표가 실제로 하는 일 - 병원마다 보유 장비가 다르므로, 진단 단계에서 받은 장비 목록에 이 매핑을 얹어 그 병원 전용 프로토콜 1장 을 만듭니다. 같은 프로그램을 파는 것이 아니라 같은 설계 방식을 파는 것 이며, 그래서 병원이 늘어날수록 우리 제작 시간은 줄어 들고 상품은 매번 그 병원 것이 됩니다. 모든 출력, 강도, 적용 여부의 최종 판단은 병원 의료진에게 있습니다.			

이 표에서 읽어야 할 것

매출의 중심은 **축 02와 03**입니다. 축 02는 병원이 이미 산 장비와 이미 고용한 관리사와 이미 비어 있는 베드를 씁니다. 즉 **한계원가가 거의 0에 가까운 매출**입니다. 축 01(수액)은 신뢰를 만드는 앵커일 뿐, 여기에만 기대면 원가율이 높아지고 차별화도 되지 않습니다.

수액 없이도 프로그램은 성립합니다

수액 처방이 부담스러운 병원에는 **축 02+03+04만으로 구성된 경량 버전**을 납품합니다. 실제로 피부과 다수는 이 구성이 더 현실적입니다.

장비 가동률이 곧 우리의 영업 논리

Q8에서 "거의 안 쓰는 장비"를 확인하면, 그 장비를 애프터케어 프로토콜의 주 구성으로 넣습니다. 원장은 이미 **지불한 돈이 살아나는 것**을 봅니다.

시점	세션명	구성 (총 01-05)	소요	환자에게 하는 말
D0 당일	리커버리 부스트	① 항산화와 항염 수액 ② 쿨링 + LED 적색 ③ 홈케어 키트 전달 ④ D0 안내 발송 ⑤ 표준 전 사진	40분	"붓기와 열감을 초기에 잡습니다"
D3-5	순환 케어	③ 림프 순환 관리 + 산소와 수분 공급 ⑤ 진정 마스크 ④ 음주와 운동 재개 안내 ⑥ 붓기 스코어 기록	30분	"가장 부어 보이는 시기를 넘깁니다"
D14	재생 부스팅	① 재생 수액 또는 스킨부스터 소량 ② 근적외 LED + 저출력 프로토콜 ③ 피부 컨디션 점검	60분	"결과가 자리 잡는 시점을 밀어 올립니다"
D28	결과 점검	⑥ 표준 후 사진과 전후 비교 리포트 출력 ④ 유지 관리 가이드 + 다음 사이클 상담	20분	"여기까지 어떻게 왔는지 같이 봅시다"

단가 구조 - 숫자는 전부 가설	가설 금액	비고
패키지 판매가 (4세션)	600,000원	단품 합계 대비 15~20% 할인 설계
재료 원가 (수액과 소모품, 키트)	150,000원	병원 실제 매입가로 교체 필요
인력과 공간 원가	90,000원	총 150분, 유허 시간 기준
병원 기여이익	360,000원	판매가의 60%
* 위 숫자는 구조를 보여주기 위한 가설입니다. 첫 병원 미팅에서 실제 매입 단가와 인건비로 교체하며, 그 전까지 어떤 수치도 확정으로 제시하지 않습니다.		

가격을 이렇게 잡는 이유

- **시술가의 20~30% 구간에 듭니다.** 200~300만원짜리 리프팅을 받은 환자에게 60만원 애프터케어는 팔리지만, 60만원 시술을 받은 환자에게는 팔리지 않습니다 - **비교 기준은 시술가이지 관리 시세가 아닙니다.** 그래서 단가는 병원의 객단가 분포(진단 Q6)를 받은 뒤 확정합니다.
- **단품으로 쪼개 팔지 않습니다.** 4세션 묶음이어야 D28까지 오고, D28까지와야 다음 시술로 연결됩니다. 회당 결제는 2회차에서 끊깁니다.
- **할인은 금액이 아니라 세션으로 합니다.** 가격을 깎으면 다음 병원의 기준가가 무너지므로, 조정이 필요하면 세션 수나 홈케어 구성으로 조정합니다.
- **기여이익 60%가 마지노선입니다.** 이 아래로 내려가면 원장이 몇 달 뒤 스스로 프로그램을 접습니다 - 팔리는 가격보다 **병원이 계속 운영할 수 있는 가격**이 중요합니다.

운영에 필요한 것 - 양쪽이 준비하는 것의 전부

병원이 준비하는 것	우리가 준비하는 것
- 유허 시간대 베드 1개 와 관리사 스케줄 - 기존 장비 사용 승인과 저출력 프로토콜의 료진 검토 - 홈케어 제품 사입 (기존 거래처 활용) - POS에 프로그램 별도 코드 생성 - 상담실장 교육 참석 90분	- 설문과 판정 로직, 프로그램 설계 전체 - 상담 스크립트와 거절 대응 문장 - 운영 매뉴얼, 동선, 예약 규칙 - 직원 교육과 2주 뒤 현장 점검 - 월간 성과 리포트와 개정

병원이 새로 사야 하는 것도, 고용해야 하는 것도 없습니다. 이것이 원장이 2주 안에 결정할 수 있는 이유입니다.

이 설계의 핵심 - D28

D28 세션은 수익이 아니라 다음 계약을 위해 존재합니다. 20분짜리 저원가 세션이지만, 전후 사진을 나란히 놓고 보는 자리이며 여기서 유지 관리 프로그램 또는 다음 시술로 연결됩니다.

애프터케어를 단발 패키지가 아니라 **재방문 루프**로 만드는 장치입니다.

나머지 시술군은 이 틀을 복제합니다

- **레이저, 색소 후 2주** - D0 쿨링과 진정 / D3 색소 관리 / D10 결과 점검 (2회 구성)
- **필러, 보톡스 후 2주** - D0 냉각과 붓기 / D7 자리잡음 점검 (경량 2회)
- **체형, 지방 후 6주** - 순환과 압박 관리 중심 6회, 홈케어 비중 최대
- **수술 후 4~8주** - 흉터와 붓기 관리 중심, 의료진 관여 비중 최대

틀을 복제한다는 것의 의미

바뀌는 것은 **사이클 길이와 세션 수, 총 01~05의 배합비**뿐이고, 구조는 동일합니다. 그래서 첫 프로그램 설계에는 2~3주가 걸리지만, **두 번째부터는 3~4일이면 됩니다.** 병원이 늘어날수록 우리 제작 원가는 내려가고 마진은 올라갑니다 - 이것이 이 사업이 규모의 경제를 갖는 유일한 지점입니다.

09 돈 - 우리가 받는 구조와 병원이 버는 구조

원장은 고정비를 싫어하고, 우리는 실적 데이터가 필요합니다. 웨어는 양쪽을 동시에 만족시킵니다

단계	제공	과금 - 가설
1. 진단 1~2주	13개 질문 기반 재방문 캡 분석 1장	무상 문을 여는 도구
2. 파일럿 3개월	프로그램 1종 + 설문 + 스크립트 + 운영 매뉴얼	셋업 300만원 + 해당 매출 15%
3. 확장 연간	프로그램 라인 전체 + 직원 교육 + 월간 리포트	월 150만원 + 매출 10%

왜 웨어 구조인가

원장 입장에서 **실패해도 손해가 30만원 단위**라면 결정은 2주 안에 납니다. 고정비 계약이면 6개월이 걸립니다.

우리 입장에서 **정산서 자체가 unit economics 데이터**가 됩니다. 병원별 전환율과 객단가, 재방문율이 영업의 부산물로 쌓이고, 이것이 다음 병원의 제안서이자 훗날 공간 사업의 설계 근거가 됩니다.

병원 수에 따른 우리 매출 - 가설 유지 기준			
계약 병원	구성	월 반복 매출	연 환산
1곳	파일럿 1 (웨어 15%)	189만원	2,268만원
3곳	파일럿 3	567만원	6,804만원
5곳	파일럿 5	945만원	1억 1,340만원
5곳 확장 전환	연간 계약 (월 150만 + 10%)	1,380만원	1억 6,560만원

※ 셋업비(병원당 300만원)는 별도이며 위 표에 포함되지 않았습니다. 고정비가 거의 없는 구조이므로 이 매출의 대부분이 그대로 남습니다.

계약서에 반드시 들어가야 하는 3줄

- **범위** - 우리가 설계한 프로그램에서 발생한 매출만 대상. 병원의 기존 시술 매출과 신규 환자 유입은 계약 범위 밖.
- **책임** - 모든 의료 판단과 처치, 처방 및 그에 따른 책임은 병원에 있으며, 우리는 설계와 운영, 교육 용역만 수행.
- **해지** - 파일럿 3개월 후 양측 자유 해지. **원장이 언제든지 그만둘 수 있어야 시작도 쉬워집니다.**

병원 입장에서의 계산 - 월 기준, 전 항목 가설		
월 시술 실현자	200명	-
설문 응답률	70%	140명
프로그램 전환율	15%	21명
패키지 객단가	600,000원	12,600,000원
병원 기여이익 (60%)	-	7,560,000원
우리 몫 (15%)	-	1,890,000원
병원 순증	-	5,670,000원 / 월

전환율 15%가 무리한 가정이라면

전환율을 절반인 **7.5%**로 낮춰도 병원 순증은 월 **283만원**입니다. 병원 입장에서 **신규 투자 0원, 신규 고용 0명**으로 만드는 숫자라는 점이 이 제안의 방어선입니다.

우리 기준으로는

파일럿 병원 1곳당 월 **189만원 + 셋업 300만원. 5곳이면 월 945만원**이고, 이 시점부터 사업은 스스로 굴러갑니다. 공간도 재고도 없이 도달하는 숫자입니다.

정산 방식

프로그램 매출은 병원 POS에서 별도 코드로 분리 집계됩니다.

월 단위 마감 후 정산서를 발행하고, 익월 정산합니다.

우리가 병원의 전체 매출을 들여다보지 않는다는 점이 신뢰의 조건입니다. 우리가 설계한 프로그램에서 발생한 금액만 계약 범위에 들어갑니다.

협상에서 가장 먼저 흔들리는 지점

원장은 거의 예외 없이 **"웨어 말고 그냥 얼마 줄 테니 해달라"**고 제안합니다. 단기 현금으로는 그쪽이 좋지만, **정액 계약은 전환율 데이터를 남기지 않습니다.**

그래서 원칙은 이렇습니다 - **첫 3곳까지는 웨어를 고수합니다.** 데이터가 필요한 구간이기 때문입니다. 4곳째부터는 정액도 받습니다. 그때는 이미 우리에게 숫자가 있습니다.

10 90일 실행 계획

이 90일은 12개월 타임라인의 1구간입니다. D1-30의 0번 파일럿이 계획 전체의 레버리지입니다

0번 파일럿은 내부 네트워크 안의 병원 한 곳에서 **무상 내부 검증**으로 진행합니다. 설문을 실제 환자에게 돌리고, 프로그램 1종을 실제로 운영해 숫자를 만듭니다. 그 숫자가 있으면 두 번째 병원부터는 **제안이 아니라 증거를 파는 것**이 됩니다.

D1-D30 0번 파일럿 개시, 리스트 확보 - 내부 네트워크 병원 1곳에서 무상 파일럿 착수 - 설문 v1 태블릿 운영 시작 - 내부 네트워크 기반 대상 원장 20곳 리스트업 - 무상 진단 리포트 포맷 완성 - 검입과 이해상충 사전 정리	D31-D60 데이터로 제안서를 바꾼다 - 0번 데이터로 제안서 v2 완성 - 외부 병원 3곳에 파일럿 제안 - 프로그램 2~3종 설계 (레이저 / 체형) - 상담 스크립트 현장 검증 및 개정 - 쉐어 계약 구조 법률 검토 완료	D61-D90 외부 병원 1곳 실제 운영 - 외부 파일럿 1곳 운영 개시 - 운영 매뉴얼 전달과 직원 교육 1회 실시 - 첫 월간 성과 리포트 발행 - 정산 프로세스 가동 - 4~5번째 병원 파이프라인 구축
완료 정의 - 설문 응답 100건 / 원장 미팅 8건	완료 정의 - 견적이 오간 건 2건	완료 정의 - 계약서 + 첫 정산서

역할	전담 영역	주간 지표
CLINICAL & SALES 의료, 영업	원장 미팅과 계약, 의료 신뢰 확보, 상담 스크립트 감수, 의료광고법 경계 판단, 내부 네트워크 기반 파이프라인 관리	신규 원장 미팅 3건 / 무상 진단 제출 1건
PRODUCT & OPS 설계, 운영	설문, 프로그램, 운영 매뉴얼, 성과 리포트 제작, 병원별 템플릿화, 정산 구조 관리	납품물 1개 완성 / 파일럿 운영 점검 1회
공통 원칙	주 3건의 원장 미팅이 나오지 않으면 이 사업은 성립하지 않습니다. 그 주에는 다른 업무를 멈춥니다.	

주간 리듬 - 90일 내내 반복하는 것

월요일	이번 주 미팅 3건 확정, 지난주 제안 건 팔로업
수요일	파일럿 병원 현장 점검, 설문 응답과 전환율 확인
금요일	주간 숫자 리뷰 - 미팅 수 / 진단 제출 수 / 응답 수 / 전환 수 4개만
상시	납품물 1개씩 완성 - 90일이면 템플릿 12종 이 쌓입니다

D90 게이트 - 넘어갈지 멈출지 판단하는 기준

- **GO** - 계약서 1건 + 첫 정산서. 이때 4~5번째 병원으로 확장하고 프로그램 라인을 늘립니다.
- **REVISE** - 미팅은 나왔으나 계약이 없다면, 문제는 상품이 아니라 **가격 또는 스크립트**입니다. 과금 구조부터 다시 만듭니다.
- **STOP** - 원장 미팅 자체가 안 나온다면 이 사업의 전제가 틀린 것입니다. **90일과 5백만원에서 멈춥니다.**

세 갈래를 **시작 전에 문서로 정해두는 것**이 이 계획의 마지막 장치입니다. 판단 기준이 없으면 사업은 멈추지 못하고 계속 흘러갑니다.

리스크 01 - 법

의료법 제27조

환자 유인, 알선 금지

매출 쉐어가 "환자 소개의 대가"로 해석되면 위법 소지가 있습니다.

우리 모델은 **신규 환자 소개가 아니라 기존 환자 대상 프로그램 설계, 운영 영역**이므로 구조적으로 더 안전한 편이나, 반드시 법률 자문으로 확인해야 합니다.

대응

계약을 "성과 연동 용역보수"로 설계 가능한지가 관건. **D31-60 안에 법률 검토 완료**. 불가 판정 시 정액 용역료 구조로 전환합니다. IV 등 모든 처치는 의료행위이므로 의사 없이 성립하지 않는다는 점도 전제입니다.

해소 시점	D31-60
해소 방법	의료 전문 법무법인 자문 1회 (예산 100~150만원)
최악의 경우	정액 용역 구조로 전환 - 사업은 계속됩니다

리스크 02 - 관계

겸업과 이해상충

0번 파일럿의 전제 조건

현직 상태에서 재직 병원을 **유상 고객**으로 두는 것은 문제가 됩니다.

이 부분이 정리되지 않으면 0번 파일럿 자체가 리스크가 되고, 90일 계획의 레버리지가 사라집니다.

대응

0번 파일럿은 무상 내부 검증으로만 진행하고, **유상 계약은 두 번째 병원 부터**. 사전에 병원 측 합의와 겸업 규정 확인이 필요하며, 이는 **착수 전에** 정리되어야 합니다.

해소 시점	착수 전 (D0)
해소 방법	병원 측 사전 합의 문서 1장 + 근로계약 겸업 조항 확인
최악의 경우	0번 파일럿을 외부 병원으로 이동 - 30일이 늦어집니다

리스크 03 - 실행

영업 시간의 절대량

대체 불가능한 자원

이 모델은 **영업이 전부**이고, 그 영업은 관계에서 나오므로 대체 인력으로 메울 수 없습니다.

주 3건의 원장 미팅이 나오지 않으면 성립하지 않습니다. 다른 사업과 병렬로 굴리는 구조라면 시작하지 않는 편이 낫습니다.

대응

착수 전 **주간 투입 시간을 숫자로 합의**합니다. 4주 연속 미팅 3건이 미달하면 **확장을 멈추고 범위를 축소**합니다 - 인력을 늘리는 것으로 해결하지 않습니다.

해소 시점	착수 전 합의, 매주 금요일 확인
해소 방법	주간 지표 4개(미팅과 진단, 응답, 전환)만 보는 30분 리뷰
최악의 경우	D90 게이트에서 STOP - 손실은 90일과 5백만원에서 끝납니다

그리고 이 사업이 가진 가장 큰 안전장치

실패의 최대 손실이 **90일과 5백만원**이라는 점입니다. 공간을 임차하지 않고, 재고를 사지 않고, 개발자를 고용하지 않고, 광고를 집행하지 않기 때문입니다. 같은 기간에 다른 노선을 택하면 **인건비만 수천만원이 선투입되고, 그때도 첫 매출은 아직 없습니다.**

12 결정 필요 사항

협의 안건이 아니라 착수 전 확정 항목입니다. 이견이 없으면 기재된 안대로 진행합니다

아래 다섯 가지는 **논의를 시작하자는 제안이 아닙니다**. 각 항목에 우리 안이 이미 정해져 있고, 필요한 것은 **확인 또는 반대 하나**입니다. 기한 안에 이견이 없으면 기재된 안으로 M0를 시작합니다.

#	결정 항목	우리 안 이견이 없으면 이대로 진행	그쪽에서 필요한 것	기한	확인
01	사업 방향	시장을 해석하는 회사가 아니라 병원에 상품을 파는 회사로 간다 . 이 문서 전체가 그 전제 위에 쓰였고, 되돌리려면 문서가 아니라 전제를 반박해야 합니다	반대 시 근거 한 줄	D+3	확인 이견
02	0번 파일럿	내부 네트워크 병원 1곳에서 무상 내부 검증 . 설문 100건. 유상 계약은 두 번째 병원부터	병원 측 합의와 검업 규정 확인	D+7	확인 이견
03	과금 구조	셋업 300만원 + 웨어 15% 로 협의를 시작하고, 첫 3곳까지는 웨어를 고수한다 . 정액 제안은 4곳째부터 받습니다	조정할 경우 수용 가능한 하한선	D+3	확인 이견
04	주간 투입 시간	영업, 의료 주 () 시간 / 설계, 운영 주 () 시간. 주 3건의 원장 미팅이 나오는 숫자 가 아니면 이 타임라인은 성립하지 않습니다	숫자 기입	D+3	기입
05	계약 주제	법인 설립 전까지는 개인 용역 계약으로 시작하고 첫 정산 후 법인으로 전환 한다. 최종 형태는 M2의 법률 검토 결과를 따릅니다	기존 파트너 우선권의 범위 확정	D+14	확인 이견

결정 전에 만들 수 있는 것은 이미 만들었습니다

병원 진단 질문지 13문항	완성 04장
환자 설문 10문항과 판정 규칙	완성 05, 06장
프로그램 설계와 장비 매핑	완성 07, 08장
과금 구조와 90일 계획	완성 09, 10장
상담 스크립트	초안 완성, 감수만 남음

남은 것은 만드는 일이 아니라 **시작 신호**입니다. 위 다섯 건이 확인되면 그 주에 원장 리스트업과 첫 미팅 요청이 나갑니다.

결정이 늦어지면 생기는 일

- 1주 지연은 1주 지연으로 끝나지 않습니다. M0가 밀리면 M3 계약, M6 5곳, M12 설계도, RE:IV 1호점이 전부 같은 기간만큼 뒤로 갑니다.
- 02와 03이 늦으면 M3 계약 자체가 불가능합니다. 웨어 구조 법률 검토를 M2 안에 끝내야 하는데, 과금 안이 확정되지 않으면 검토를 의뢰할 대상이 없습니다.
- 기다린다고 정보가 더 생기지 않습니다. 이 다섯 가지에 대한 추가 정보는 회의실이 아니라 첫 병원 미팅에서 나옵니다. 시작해야 알 수 있는 것을 시작 전에 알 수는 없습니다.

틀렸을 때의 비용은 **90일과 5백만원**으로 이미 고정해 두었습니다. 그보다 작은 리스크로 이 질문에 답할 방법은 없습니다.

그래서

**이 제안의 리스크는
틀리는 것이 아니라
늦는 것입니다.**

결정을 미루는 것도 결정입니다. 다만 그 비용은 이 사업이 아니라 **RE:IV가 냅니다**.

다음 주 월요일에 원장 리스트 20곳과 첫 미팅 3건을 잡습니다. 위 다섯 건에 이견이 없다면 그대로 진행하겠습니다.

13 12개월 안에 RE:IV까지 간다

공간을 먼저 짓지 않기 때문에 오히려 빨라집니다

이 타임라인의 전제는 하나입니다. **돈이 아니라 병원에서 보낸 개월 수가 우리를 앞으로 밀어줍니다.** 그래서 자본을 더 넣어 앞당길 수는 없지만, **시작을 3개월 뒤로 미루면 RE:IV도 정확히 3개월 밀립니다.** 아래 다섯 구간은 각각 앞 구간의 산출물 없이는 시작되지 않습니다.

M0 - M3 구축과 첫 계약 프로그램 1종(리프팅 4주)과 설문, 스크립트, 매뉴얼 완성 내부 무상 파일럿으로 설문 100건 검증 PoC 유료 병원 1곳 계약 및 운영 개시	M4 - M6 5곳으로 늘린다 프로그램 3종으로 확장 (레이저, 체형 추가) 4곳 추가 계약, 동시 운영 5곳 정산 사이클 정착	M7 - M12 체계로 묶는다 시술군별 프로토콜 라이브러리 4종 확정 고객 프로파일 정리 RE: 코드 5종의 실제 분포와 코드별 객단가 병원별 unit economics 확정	M13 - M18 RE:IV로 구현한다 파일럿 병원 안 삽입삽으로 1호점 오픈 우리가 설계한 프로토콜을 우리 이름으로 운영 평수, 침대 수, 인력, 메뉴를 12개월 데이터로 결정	M18 이후 IP, 라이선스, PB 프로토콜 체계를 RE:IV IP 로 확정 병원과 사업자에 브랜드와 프로토콜 라이선스 홈케어 키트를 PB 로 전환
게이트 계약서 1장 + 셋업비 입금	게이트 월 반복 매출 945만원 (가설) 누적 설문 약 1,000건 / 판매 약 150건	게이트 RE:IV 1호점 설계를 실측으로 작성 누적 설문 약 5,200건 / 판매 약 780건	게이트 오픈 후 3개월 연속 목표 가동률	게이트 라이선스 1건 또는 PB 첫 생산

같은 1호점을 공간부터 시작했다면		
비교 축	공간부터 시작하는 경우	이 제안
1호점 오픈 시점	자본 조달에 걸리는 시간에 좌우됩니다	M13 - M18 , 우리가 통제합니다
오픈 시점의 설계 근거	벤치마킹과 추정	정산서 40회, 설문 약 5,200건, 판매 약 780건
오픈 전까지의 누적 매출	0원	약 8,500만원 (쉐어 + 셋업비, 가설)
1호점의 첫 고객	새로 모아야 합니다	이미 계약된 병원 5곳과 그 환자
틀렸을 때 되돌리는 비용	임차 계약과 인테리어	90일과 5백만원

왜 이 속도가 가능한가

- **첫 프로그램만 오래 걸립니다.** 첫 설계에 2~3주, 두 번째부터는 3~4일. 1곳에서 5곳으로 가는 시간이 1곳을 만드는 시간보다 짧습니다.
- **운영은 병원이 합니다.** 우리는 설계와 교육, 리포트만 담당합니다. 병원이 늘어도 우리 인력은 그대로입니다.
- **1호점을 새로 짓지 않습니다.** 파일럿 병원 안 삽입삽이므로 임차, 인허가, 의료인력 채용이 전부 빠집니다.
- **자본 조달도 타임라인 안에 있습니다.** 12개월 누적 매출 약 8,500만원과 정산서 40회가 1호점 자본의 근거이자 일부가 됩니다.

무엇이 밀리면 전부 밀리는가

- **법률 검토가 크리티컬 패스입니다.** 쉐어 구조 자문이 M2 안에 끝나야 M3 계약이 성립합니다. 여기가 밀리면 뒤의 네 구간이 통째로 밀립니다.
- **6곳째부터는 인력이 필요합니다.** 2명으로 감당되는 상한은 동시 5곳입니다. M6의 월 945만원이 그 채용비를 감당하는 구조여야 합니다.
- **M12의 데이터 품질이 1호점의 성패입니다.** 설문과 정산이 같은 규격으로 쌓이지 않으면 5,200건이 있어도 설계 근거가 되지 못합니다.
- **속도를 지키는 방법은 하나입니다.** 매주 금요일에 미팅 수, 진단 제출 수, 응답 수, 전환 수 네 개만 봅니다. 이 네 개가 타임라인의 실제 속도계입니다.

한 문장으로

**12개월은 공간을
미루는 기간이 아니라
공간의 설계도를
사는 기간입니다.**

같은 시점에 같은 공간을 열되, 한쪽은 추정으로 열고 한쪽은 실측으로 엽니다.

14 무엇이 남고, 그것으로 무엇을 하는가

파일럿의 진짜 산출물은 매출이 아니라 팔 수 있는 자산입니다

병원 다섯 곳에서 12개월이 지나면 우리에게 남는 것은 정산서만이 아닙니다. **실제 환자에게서 검증된 설계, 실제로 전환된 문장, 그리고 그것을 함께 만든 병원들이 남습니다.** RE:IV는 그 자산을 우리 이름으로 구현하는 자리이고, 그때 비로소 **메디컬 웰니스의 표준을 우리가 쓰게 됩니다.**

M12까지 쌓이는 자산			
자산	M12 시점의 실물	왜 복제되지 않는가	RE:IV에서 하는 일
프로토콜 IP	시술군별 프로그램 4종, 실제 병원에서 37개월 분 운영된 기록	문서가 아니라 돌려본 것만 남기 때문입니다. 실패한 구성까지 알고 있는 쪽이 이깁니다	그대로 시술 메뉴가 됩니다
전환율과 객단가	정산서 40회, 프로그램 판매 약 780건	병원 수와 개월 수만큼만 정확해집니다. 돈으로 앞당길 수 없습니다	공간 손익을 추정이 아니라 실측 으로 세웁니다
고객 프로파일	설문 약 5,200건, RE: 코드 5종의 실제 분포와 코드별 객단가	환자가 자기 상태를 말하는 방식은 조사로 나오지 않습니다	메뉴 구성비와 베드 수를 정하는 근거
병원 네트워크	계약 병원 5곳과 그 원장들	관계는 자본으로 사지 못합니다	의료 파트너이자 1호점의 첫 고객
상담 스크립트	실제로 전환된 문장만 남긴 라이브러리	상담실 밖에서는 검증되지 않습니다	우리 상담실에서 그대로 씁니다

확장 01

RE:IV IP

시술군별 프로토콜 체계와 RE: 코드를 하나의 IP로 확정합니다.

왜 M18인가 5,200건의 응답과 780건의 판매로 뒷받침되기 전에는 IP가 아니라 아이디어입니다. 검증 기록이 붙는 순간 같은 문서의 가치가 달라집니다.

투자 유치와 라이선스 협상의 근거 자산

확장 02

라이선스

브랜드와 프로토콜, 교육, 운영 매뉴얼을 패키지로 병원과 사업자에 공급합니다.

왜 이 방식인가 직영은 자본과 인력이 같이 늘지만, 라이선스는 **공간을 더 짓지 않고 확장**합니다. 1호점이 증거로 존재할 때 협상력이 가장 큼니다.

라이선스 피 + 로열티, CAPEX 없음

확장 03

PB

홈케어 키트를 사업에서 자사 제품으로 전환합니다.

왜 이 순서인가 12개월간 어떤 제품이 몇 개 나갔는지 정확히 알고 시작하기 때문에, 재고 리스크가 거의 없는 유일한 진입 방식입니다. 수요를 만든 뒤에 만드는 제품입니다.

사업 마진 회수 + 반복 구매 매출

마지막으로

우리는 메디컬 웰니스를 설명하는 회사가 되려는 것이 아닙니다.
병원에서 실제로 작동하는 시술 이후를 만들고, 그것을 RE:IV로 구현해
메디컬 웰니스의 표준을 우리가 쓰게 됩니다.

표준은 선언이 아니라 축적입니다. 병원들이 우리 설계를 쓰기 시작할 때 자동으로 됩니다. 그 시작은 공간도 자본도 아니고, 다음 주 원장 미팅 3건입니다.